Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO / IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
UNIDAD ASISTENCIAL RESPONSABLE UNITAT ASSISTENCIAL RESPONSABLE	Servicio de Urgencia Hospitalaria
SERVICIO SERVEI	URGENCIAS
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	28/10/2022
FECHA Y HORA DE ALTA DATA I HORA D'ALTA	28/10/2022

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT			
PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		Nº Hª CLÍNICA Nº Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	F. NACIMIENTO D. NAIXIMENT	09/11/1938
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Datos generales del paciente / Dades generals del pacient

Procedencia / Procedència: PARTICULAR

Motivo de la atención / Motiu de l'atenció: .

Antecedentes / Antecedents: Niega alergias medicamentosas conocidas.

Antecedentes Respiratorios:
-Ex-fumadora desde hace mas de 40 años de 4 cig/dia.
-Tras viaje prolongado en coche a Alemania, TVP + TEP bilateral en Francia en 2016 y en 2022. En tratamiento actualmente con Rivaroxaban.
- TBC en la infancia (TAC del 2017 hallazgos compatibles con cambios post TBC).
- EPOC.
- Portadora de VMNI por SAOS (BiPAP puesta en Navarra).
- Portadora de OCD 16 h 2 lpm.

Antecedentes personales:
- Dislipemia.
- Ictus vertebrobasilar en septiembre 2021.
- Deterioro cognitivo desde ingreso por ictus vertebrobasilar en estudio por Neurología.
- Elevación hemidiafragma derecho.
- Insuficiencia tricuspídea moderada.

Tratamiento habitual:
- MEPIRAMINA FRASCOS SOL ORAL 25 MG/5 ML DE 250 ML.
- PROTALON 10MG 112 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG.
- BROMURO DE TIOTROPIO CAPSULAS + DISPOSITIVO 18 MCG.
- PREDNISONA COMPRIMIDOS 30 MG.
- AUGMENTINE 500/125MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA.
- RIVAROXABAN 20 MG / 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA.

Social: vive con el marido. Barthel 80.

Refiere 2 vacunas para SARS-2 aunque no constan en abucasis.

Marido Pierre tlf 667493227

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual: Mujer de 83 años que acude a SUH por clínica de disnea y aumento de tos habitual de 4-5 días de duración. Además, refiere problema con OCD y no se consigue contactar con Oximesa. Refiere aumento de disnea habitual y accesos de tos nocturnos con dificultad para la expectoración. Autoescucha de ruidos respiratorios. Sensación distérmica sin termometrar fiebre. No síndrome miccional.

En tratamiento con Augmentine desde 27/10/22.

Exploración física / Exploració física: Constantes: TA 119/57 mmHg FC 55 lpm SaO2 92% GN a 1 lpm. Afebril.

Buen estado general. Consciente y orientada. Normohidratado y normocoloreado. Eupneico en reposo.
- AC: Tonos rítmicos, sin soplos.

- AP: murmullo vesicular con sibilantes y roncus dispersos.
- Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. No palpo masas ni megalias. No signos de peritonismo.
- MMII: no edemas, pulsos palpables.

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries:

RX TÓRAX: Elevación diafragmática derecha. No se objetivan consolidaciones ni infiltraciones en el momento actual. No pinzamiento de los senos costofrénicos. Silueta cardiomediastínica normal.

Evolución / Evolució:

GSA aire ambiente
POC SATURACION OXIGENO 97,7 %
POC PH SANGUINEO 7,360
POC PCO2 SANGUINEO 43,0 mmHg
POC PO2 SANGUINEO 94,0 mmHg
POC EXCESO BASE ACTUAL -1,3 mmol/L
POC BICARBONATO STD 23,9 mmol/L
POC HEMATOCRITO 45,0 %

ANALÍTICA URGENCIAS 28/10

BIOQUIMICA
GLUCOSA * 156 mg/dL (70 - 110)
UREA 48 mg/dL (10.0 -- 50.0)
CREATININA 0,81 mg/dL (0,51 - 0,95)
FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 66,89 ml/min/sup (60.00-200.0)
SODIO 137 mmol/L (134-145)
POTASIO 4,77 mmol/L (3.50-5.00)
CLORO 101 mmol/L (95-105)
GPT 13 UI/L (10-37)
PROTEINA C REACTIVA * 22,90 mg/L (1.00-10.0)
NT- PROBNP 101 pg/mL (20 - 125)

HEMOSTASIA
T. PROTROMBINA * 14,3 seg (9,0 - 13,0)
INDICE DE QUICK 74,0 % (70,0 - 120,0)
INR * 1,24 (0,80 - 1,20)
TP RATIO * 1,24 (0,80 - 1,20)
TTPA RATIO 0,98 (0,80 - 1,25)
T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 31,0 seg (25,1 - 38)
FIBRINOGENO * 701,00 mg/dL (200,00 - 400,00)

HEMOGRAMA
HEMATIES 4,57 x 10^6/µL (4,20 - 6,10)
HEMOGLOBINA 13,9 g/dL (12,0 - 18,0)
HEMATOCRITO 42,3

% (37,0 - 52,0)
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO
92,6 fL (80 - 94)
HBG CORPUSCULAR MEDIA
30,5 pg (27,0 - 31,0)
CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA
* 32,9 g/dL (33,0 - 37,0)
RDW-CV 13,7 %
(11,6 - 14,5)
LEUCOCITOS 6,20 x
10^3/µL (4,80 - 10,80)
NEUTROFILOS 4,70 x
10^3/µL (1,90 - 8,00)
LINFOCITOS 1,10 x
10^3/µL (0,90 - 5,20)
MONOCITOS 0,40 x
10^3/µL (0,16 - 1,00)
EOSINOFILOS 0,00 x
10^3/µL (0,00 - 0,80)
BASOFILOS 0,00 x
10^3/µL (0,00 - 0,20)
PLAQUETAS 214 x
10^3/µL (130 - 400)

Se niega a realizarse Ag COVID-19.
La paciente permanece hemodinámicamente y clínicamente estable en todo momento. Se administra salbutamol + atrovent 2 puffs en tandas durante 1 hora y Actocortina 200 mg IV, con mejora de la sintomatología. Se realizan pruebas complementarias realizando analítica sanguínea sin objetivar leucocitosis con neutrofilia. Discreta elevación de reactantes de fase aguda. Hemostasia en rango. Iones normales y función renal normal. No se realiza Ag COVID-19 por negativa de la paciente. Radiografía de tórax sin cambios con respecto a previas. Dada la normalidad de las pruebas complementarias y la mejora clínica que presenta la paciente, se decide alta hospitalaria con seguimiento y control por Médico de Familia.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal: BRONQUITIS AGUDA

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta:
- Observación domiciliaria.
- MANTENER tratamiento domiciliario habitual.
- AÑADIMOS: Symbicort 1 inhalaciones cada 12 horas.
- Control y seguimiento por Médico Familia.
- Se explican signos y síntomas por lo que acudir de nuevo.

Recomendaciones / Recomanacions:
Recuerde que tiene usted la/s siguiente/s cita/s:
El Viernes 31 de Marzo de 2023 a las 13:00: ECR-(LX-MARAVALL/V-FRANCH); ubicada en CE Jaume I Planta 4 Puerta 48 de C.EE. JAIME I - CASTELLO
El Miércoles 08 de Febrero de 2023 a las 12:50: ACOS(NUEVOS ANTICOAGULANTES); ubicada en Planta 1 Bloque B Puerta 62 de HOSPITAL GENERAL DE CASTELLO
El Viernes 12 de Mayo de 2023 a las 13:10: DRA.CAMPILLO; ubicada en Planta 1 Bloque A Puerta 07 de HOSPITAL GENERAL DE CASTELLO

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta: MÉDICO DE CABECERA

Responsable:

Sección / Secció: URGENCIAS

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 28/10/2022